

Beobachten

Beobachten setzt im Gegensatz zum Wahrnehmen ein Bewusstsein und eine Absicht voraus. Wahrnehmung bildet die Grundlage des Beobachtungsprozesses und ist im Wesentlichen durch das bewusste Lenken der Aufmerksamkeit auf eine Erscheinung bestimmt. Beobachten ist ein aktiver, dynamischer Vorgang. Diese Möglichkeit der zielgerichteten Wahrnehmung wird genutzt, um ein Objekt oder ein Phänomen genau zu untersuchen, Veränderungen festzustellen und nachfolgendes Handeln zu ermöglichen. In der professionellen Pflege ist die Beobachtung der wichtigste Schritt, um Pflegemaßnahmen planen, durchführen und überprüfen zu können.

Beobachtungsarten

Subjektive Beobachtung: Eine Person beobachtet eine andere Person. Die Beobachtung geschieht nur aus dem Blickwinkel der einen Person. Gefühle und Vorurteile der beobachtenden Person beeinflussen die Beobachtungssituation.

Beispiel: Eine Pflegekraft bemerkt bei einer älteren Patientin in der häuslichen Pflege eine zunehmende depressive Verstimmung. Um ihre subjektive Beobachtung zu überprüfen, strebt sie ein Gespräch mit den Angehörigen der Patientin an.

Objektive Beobachtung: Eine Person wird unabhängig vom persönlichen Blickwinkel beobachtet. Die Beobachtung geschieht auf sachlicher Ebene, Gefühle und Vorurteile der beobachtenden Person werden ausgeschaltet. Eine objektive Beobachtung ist schwierig, da Wahrnehmung und Beobachtung immer von individuellen Faktoren des Beobachtenden beeinflusst wird. Eine objektive Beobachtung nur durch eine Person zu gestalten ist daher kaum möglich. Beobachten mehrere Personen eine andere Person oder einen Sachverhalt und kommen sie zu gleichen oder ähnlichen Ergebnissen, wird diese Beobachtung annähernd objektiv. In der professionellen Pflege ermitteln Pflegenden objektive Daten mithilfe von zuverlässigen Messinstrumenten.

Beispiel: Das Geburtsgewicht eines Neugeborenen wird mithilfe einer entsprechenden Säuglingswaage, die Körpertemperatur eines fiebernden Kleinkinds mit einem Fieberthermometer festgestellt.

Selbstbeobachtung: Eine Person richtet ihre Beobachtung auf sich selbst. Die Selbstbeobachtung liefert im Rahmen einer professionellen Pflege wichtige Aspekte zum Aufbau einer Beziehung zwischen Patienten und Pflegekraft. Der Pflegebedürftige kann durch das Wahrnehmen und Beschreiben seiner eigenen Gefühle und körperlichen Symptome wichtige Informationen für die Erhebung seines individuellen Unterstützungsbedarfs liefern. Die Pflegekraft berücksichtigt die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung des Patienten. Sie nimmt diese Informationen in ihrer Pflegeerhebung auf und plant geeignete Pflegemaßnahmen. Im Gegenzug dazu kann die Pflegekraft durch die Beobachtung ihrer eigenen Gefühle und Reaktionen ihr Handeln in der Pflegesituation reflektieren und evaluieren.

Beispiel: Ein Erwachsener beobachtet, dass nach langer Arbeit am Computer seine Augen brennen und ihm sein Sehvermögen beeinträchtigt erscheint. Er reduziert die Arbeitszeit am Computer und beobachtet sich selbst bezüglich einer Veränderung der wahrgenommenen Symptome. Stellt sich keine Besserung ein, sucht er einen Augenarzt auf.

Fremdbeobachtung: Eine Person richtet ihre Beobachtung auf eine andere Person.

Fremdbeobachtung ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen pflegerischen Handelns.

Beispiel: Die Pflegekraft beobachtet während der Körperpflege eines älteren Herrn dessen gerötetes und überhitztes Gesicht sowie kühle Extremitäten. Sie kontrolliert die Körpertemperatur des Patienten. In einem anderen Fall beobachtet die Pflegefachkraft, dass eine junge Krebspatientin zunehmend ihre Mahlzeiten kaum angerührt zurückgehen lässt. Sie spricht die Patienten darauf an. Bei der Fremdbeobachtung in der Pflege ist eine möglichst objektive Beobachtung wesentlich. Nicht eindeutige, subjektive Beobachtungen sollten daher mit dem Patienten und auch im pflegerischen und/oder im interdisziplinären Team besprochen werden.

Teilnehmende Beobachtung: Der Beobachter ist in der Beobachtungssituation gleichzeitig Handelnder. Pflegende beobachten Pflegebedürftige während der Durchführung von Pflegemaßnahmen. Während der Körperpflege können Pflegende z. B. den Hautzustand, die motorische Beweglichkeit und auch die emotionale Verfassung des Patienten erfassen. Während einer teilnehmenden Beobachtung ist die Gefahr einer Datenverfälschung geringer, da der Patient sich nicht zwingend beobachtet fühlt.

Nichtteilnehmende Beobachtung: Der Beobachter ist nicht an der Situation beteiligt, sondern beobachtet aus einer neutralen, nicht aktiven Position heraus. So können Verhaltensmuster, z. B. die Beziehungsgestaltung in der Pflege zwischen Pflegekraft und Patienten, beobachtet und festgehalten werden. Die Gefahr einer Datenverfälschung ist dabei relativ hoch, denn wenn Menschen wissen, dass sie beobachtet werden, ist ein normales Verhalten meist schwer. Körperliche Funktionen werden im Vorfeld beeinflusst, wenn der Patient Kenntnis von der geplanten Beobachtung hat. Wird ein Patient z. B. darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Pflegekraft seine Atmung beobachten will, ist eine normale Atmung für ihn kaum möglich.

Beobachtung im Rahmen pflegerischen Handelns: Pflegende erfassen den körperlichen, seelischen und emotionalen Zustand eines Pflegebedürftigen. Durch Beobachtung ermittelte Daten liefern die grundlegenden Aspekte zur Planung und Überprüfung einer individuellen Pflege. Ein fachlicher Umgang mit den Daten im Sinne von Auswertung, Dokumentation und Weitergabe trägt dazu bei, potenziellen Gefährdungen für den Patienten vorzubeugen oder ein rechtzeitiges Eingreifen zu ermöglichen.